

Información Paciente

Nombre : Javiera Paz Sobino Gómez
Edad : 25a 5m 3d
Dirección : Pasaje Laguna 926

Rut : 19.420.302-0
Fecha Nacto: 04/08/1997
Comuna : Renca

N° Archivo : 2300268
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 9999 9999

N° Epicrisis
336402

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalizacion
Unidad de Egreso : Emergencia Adulto

Fecha Ingreso : 04/01/2023 18:04
Fecha Egreso : 07/01/2023 13:01

Días Estadía : 3

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de conciencia.

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Epicrisis:
FI:04/01/23
FE:07/01/23

Ingreso:

Extraviada desde el 31/12/22 (info entregada por madre, hay denuncia de presunta desgracia en carabineros), es encontrada el 04/01/23 en cerros de pirque comprometida de conciencia. En traslado ambulancia personal a bordo refiere convulsión tónico clónica por lo que se decide IOT. Se sedó con midazolam 15 mg y se bloqueó con succinilcolina 100 mg y rocuronio 20 mg.

Ingres a REA HSR tarde del 04/01 descrita como normocárdica, hipertensa leve, saturando 100% ventilada con bolsa mascarilla, GCS 7 (O1:V1:M5), isocórica.

Se solicita TAC cerebro y cuello con cte sin hallazgos agudos de hemorragia o fractura, pendiente informe. TAC TAP Foco de condensación en el lóbulo inferior izquierdo, hallazgo que pudiese estar determinado por una patología inflamatoria - Infecciosa versus cambios post contusionales. Exámenes de lab, todos dentro de rango normal. Se inicia tto profilactico con n-acetil cisteina (x17 dosis) y ampicilina/sulbactam por foco condensación. En la noche del 04/01 (aprox 21:30hrs) se decide extubar.

Evolucion durante hospitalizacion:

HDN: Estable autosostenido, normocardica normotensa sin requerimientos de DVA ni gatillo transfusional. Semantiene en MNI.

Respiratoria: Ingres a comprometida de conciencia sin proteccion de via aerea por lo que se decide intubar. Se extuba el 04/01 la noche sin incidentes. Posteriormente evoluciona favorablemente, sin requerimientos de O2 suplementario, saturando adecuadamente .

Infeccioso: Al ingreso destaca en TAC de torax foco de condensacion, por lo que se deja ATB endovenosa (Ampicilina/sulbactam). Ademas, se deja N acetil cisteina por 17 dosis.

Se deja azitromicina 1 gramo por 5 dias para NAC. En contexto de sospecha de violencia sexual se inicia protocolo de victimas de violencia sexual.

Se dejo ceftriaxona 250 mg IM x 1 VEZ + metronidazol 2 gramos x 1 vez para tratar infeccion de transmision sexual

Fecha Epicrisis : 07/01/2023 13:12

Fecha Última Actualización: 07-01-2023 13:12:46

Página 2 de 2

(Gonococo y clamidia).Ademas, se deja profilaxis para VIH por un mes. Ritanovir, Tenofovir y Darunavir. Se Coversa con Matrona de Vicctimas de violencia sexual,y seindica que debe acudir a UNACEFF CDT pasillo 2 o en su consultorio para iniciar seguimiento.

Medio interno: Sin alteraciones durante hospitalizacion.

Diagnóstico de Egreso

VIOLENCIA FISICA -
ABUSO SEXUAL -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Condicion de egreso:
HD estable, normotensa,normocardica afebril sin requerimientos de 02 suplementario.
Presenta buena tolerancia oral sin na

Plan Post Alta

Indicaciones:

- 1.-Reposo relativo
- 2.-Regimen liviano
- 3.- Azitromicina 1 gramo al dia por 5 dias.
- 4.- Ritonavir 100 mg, 1 comprimido al dia via oral por 30 dias.
- 5.-Tenofovir/Emtricitabina, 300/200, 1 copm cada 24 hrs por 30 dias.
- 6.- Darunavir 400mg, 2 comprimidos cada 24horas por 30 dias.
- 7.-Clorfenamina 4 mg cada 12 horas en caso de picazon

Controles:

Acudir al consultorio respectivo para iniciar seguimiento y controles en programa de victimas de violencia sexual.

Si tiene problemas acudir en CDT Pasillo 2 HSR, UNACEFF para iniciar seguimiento.

Control con psiquiatria o medico de consultorio para evaluar posible TEPT. No se realiza IC yaque paciente es de quinta normal.

Consultar al SU

En caso de compromiso de conciencia, sangrado por boca dolorabdominal intenso, dificultad ppara respirar o en caso que estima necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Rodrigo Andrés Arias Zuñiga
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 07/01/2023 13:12

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:51

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar